

Cas courants-anamnèse et statut

Epilepsie

-Circonstances (temps, prodrome, amnésie circonstancielle et durée, premier épisode ?, élément déclencheur, toxiques +++, fièvre, épisode infectieux, comptage)

-Crise : témoins ? Yeux ouverts vs fermés ? Mouvements (tonico-clonique etc) ? Pâleur ? Respiration ?

-Phase post critique : amnésie circonstancielle ? Morsure de langue ?

Statut : général : pv, gsc, orientation, pâleur, cyanose

bouche : morsure !!, neuro (dd méningite), cardio, resp, abdo (+loges rénales pour infection !), uro,

Cardio: normocarde, B1B2 bien frappés sans souffle audible, TRC<3 sec, pouls périphériques palpables et symétriques, bien perfusé, mollets souples et indolores, ballant conservé, pas d'OMI.

Resp: eupnéique, murmures vésiculaires symétriques, pas de bruits surajoutés, pas de cyanose, ampliation thoracique symétrique, pas d'orthopnée

Abdo: bruits normaux en fréquence et intensité dans les 4 quadrants, pas de douleurs/sensibilité à la palpation, pas de défense, pas de détente, pas de masse, pas d'organomégalie,

Urogénital: loges rénales souples et indolores

Neuro: réveillé, orienté dans les 3 modes, GCS 15,

- pas de raideur de nuque;

- NC: pupilles isocores isoréactives, pas de déficit des champs visuels, oculomotricité normale, pas de nystagmus, sensibilité et motricité de la face sp, audition normale ddc, voile du palais symétrique, SCM et trapèze sp, motricité de la langue sp;

- voies longues: sensibilité et motricité des 4 membres dans la norme, Barré et Mingazzini tenus, réflexes rotuliens et bicipitaux normovifs, RCP en flexion ddc; marche stable, talon pointe tenues, funambule sp Romberg négatif, Trendelenburg sp.

- épreuves cérébelleuses : épreuve doigt nez et talon genou dans la norme, marionnettes sp

INV : -labo habituel + lactate + magnésium et calcium + osmolalité

Malaise avec/sans PC (perte de connaissance)

[5-16_syncope.pdf \(hug.ch\)](#)

1. Y a pc ou pas ? Si oui → suspicion syncope, si non → pas de syncope

-Circonstances (voir épilepsie, nausée, vomissement, douleurs abdominales, sueurs, froid)

-Crise : témoins ? Yeux ouverts ? Respiration ? Pouls ? Mouvements ?

-Phase post critique : amnésie ? Urine ? Pâleur ? Morsure de langue ? Céphalées ? Cyanose ?

-Habituel : cardiovasc : dyspnée, orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne, nycturie, omi, tensions habituelles. Neuro : frcv, anticoag/plaquettaire. Antécédent familial : pc, mort subite !!

Statut : général : pv, gsc, orientation, pâleur, cyanose, fièvre, frisson. Habituel pour suite
DD : cardiaque, vagal, ait/avc, métabolique (glycémie !),

Céphalées non traumatiques

Alcoolisation aigue

Douleurs abdominales

Dyspnées, tachypnée

Hémoptysies

Saignement digestif

Crise hypertensive

Hypotension

Hypoglycémie

Hyperglycémie

Filière stroke

Décompensation diabétique

Troubles électrolytiques

